

Certificat de înregistrare a medicamentului – nr. 20910 din 28.07.2014

Modificare din 20.08.2015 Anexa1

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

MIGRETIL comprimate filmate

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Paracetamol 400 mg, cafeină 100 mg, tartrat de ergotamină 1 mg, alcaloizi de Belladonna 0,1 mg;

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate.

4.DATE CLINICE**4.1.Indicații terapeutice**

Tratamentul atacurilor de migrenă. Nu este indicat ca tratament preventiv.

4.2.Doze și mod de administrare

Cu excepția altor indicații medicale, dozele vor fi următoare:

Adulți: se administrează câte 2 comprimate în timpul aurei sau la debutul cefaleei. Dacă este necesar, se va administra încă un comprimat peste 30 min; această doză poate fi repetată încă după 30 min.

Adolescenți: câte 1 comprimat în timpul aurei sau la debutul cefaleei. Dacă este necesar, se va administra încă un comprimat peste 30 min.

Nu se administrează la copii cu vârsta sub 12 ani.

Mod de administrare

Comprimatele trebuie luate cât mai curând posibil după primele semne ale unui atac de migrenă.

Nu se vor administra mai mult de 6 comprimate pe zi sau 10-12 comprimate pe săptămână.

Comprimatele se vor înghiți întregi, cu o cantitate suficientă de apă.

4.3.Contraindicații

Hipersensibilitate la oricare dintre componentele preparatului. Sarcina și perioada de alăptare, alcoolism activ, insuficiență hepatică și renală severă, septicemie.

Angioplastie sau intervenție chirurgicală vasculară recentă sau planificată, boli vasculare periferice ocluzive, hipertensiune arterială necontrolată, boli coronariene. Se va evita administrarea concomitentă de macrolide (eritromicina, claritromicina și troleandomicina), inhibitori de protează (de exemplu, ritonavir și indinavir), antifungice azolice (de exemplu, ketoconazol și itraconazol), și alte medicamente care inhibă izoenzima CYP3A4 a citocromului P450.



4.4. Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Riscul de complicații crește în cazuri de infecție severă sau insuficiență renală semnificativă, precum și la pacienții vârstnici. Având în vedere posibila reducere a fluxului sanguin cerebral, cardiac sau periferic, acest medicament nu ar trebui să fie de preparat de elecție la vârstnici.

La pacienții cu tulburări de anxietate, cafeina poate exacerba simptomele.

Trebuie evitată utilizarea concomitentă de băuturi care conțin cafeină.

Pacienții cu hipertrofie de prostată, retenție urinară, boli gastrointestinale ocluzive sau glaucom pot suferi de reacții adverse cauzate de alcaloizi de Belladonna, deși dozele incluse în MIGRETIL sunt foarte mici.

Dozele nu trebuie crescute sau administrarea preparatului nu va fi prelungită din cauza riscului de ergotism (vasoconstricție intensă), gangrenă, fibroză vasculară cardiacă, fibroză retroperitoneală sau fibroză pleuropulmonară.

4.5. Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Xantinele pot crește efectele stimulatoare ale beta-adrenergicelor. Administrarea concomitentă de stimulatoare ale sistemului nervos central poate induce efecte cumulative și adverse, precum nervozitate, iritabilitate, insomnie, convulsii și aritmii. Administrarea concomitentă de inhibitori ai monoaminooxidazei poate provoca tahicardie, aritmii sau hipertensiune arterială. Cafeina antagonizează efectele adenozei și beta-blocantelor.

Administrarea concomitentă de vasoconstrictoare sistemice (cocaina, epinefrina, metaraminol, metoxamina, noradrenalina, fenilefrina, soluții anestezice locale cu vasoconstrictoare, amine simpatomimetice), precum fumatul, potențează efectele vasopresoare ale alcaloizilor de ergot. Aceste medicamente antagonizează efectele vasodilatatoare ale nitroglicerinei. Trebuie luate precauții speciale la administrarea concomitentă de propanolol și doze mari de alcaloizi de ergot, din cauza riscului de vasoconstricție periferică severă.

Efectele vasoconstrictoare ale alcaloizilor de ergot sunt aditive cu cele ale sumatriptanului. Astfel, la administrarea concomitentă a acestor medicamente trebuie să respecte un interval de timp de cel puțin 24 de ore. Administrarea de ergotamină la persoanele, care fumează în cantități excesive, poate crește riscul de ischemie vasculară periferică, deoarece nicotina are, de asemenea, efecte vasoconstrictoare. Administrarea concomitentă de sibutramină poate crește riscul de hipertensiune arterială și/sau tahicardie.

Consumul excesiv de alcool poate crește riscul de hepatotoxicitate indusă de paracetamol. Cafeina potențează efectele altor xantine, și poate reduce eliminarea lor. Macrolidele (precum eritromicina, claritromicina și troleandomicina), inhibitori de protează (de exemplu, ritonavir și indinavir), antifungice azolice (de exemplu, ketoconazol și itraconazol), și alte medicamente care inhibă izoenzima CYP3A4 a citocromului P450 reduce metabolizarea alcaloizilor de ergot, crescând riscul de vasospasm, ischemie cerebrală sau ischemie periferică severă.

4.6. Sarcina și alăptarea

Nu se administrează în sarcină și perioada de alăptare.

4.7. Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

La administrarea dozelor recomandate preparatul nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8. Reacții adverse

La administrarea dozelor recomandate, MIGRETIL de regulă este bine tolerat.

Totuși pot apărea următoarele reacții adverse:

Tulburări gastrointestinale: simptome de iritație gastrică, greață, vomă, diaree.

Tulburări ale sistemului nervos: insomnie, nervozitate, vertij, mialgie, parestezie și scăderea puterii a membrilor inferioare.

Tulburări cardiace: efectele de vasoconstricție pot fi înregistrate în orice vas, cu o mare variabilitate individuală. Aceste efecte se caracterizează prin extremități reci, amorțite și dureroase, cu sau fără parestezii.

De asemenea, sunt descrise alte simptome, cum ar fi lipsa pulsului, bradicardie, fibroză valvulară, cianoză, edem, modificări ale electrocardiografelei, hipertensiune arterială, ischemie, precordialgie, tahicardie, vasospasm.

Hipersensibilitate: mâncărime.

Altele: procesele de fibroză, în afară valvelor cardiace, ar putea să se dezvolte în spațiul retroperitoneal și interstițiu pulmonar.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acesta permite monitorizarea în continuare a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate, prin intermediul sistemului național de raportare disponibil pe site-ul oficial al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: www.amed.md.

4.9. Supradozaj

Cazurile de supradozaj sau intoxicație acută pot apărea ocazional la pacienții care iau doze mai mari decât cele recomandate sau la subiecții cu tendință de suicid.

Simptomele pot include greață, vărsături, dureri abdominale, cefalee, iritabilitate, agitație, scotoame, tinitus, tremor, tahicardie, aritmii, creșterea diurezei, mialgii, parestezii, slăbiciune în membrele inferioare, extremități reci, amorțite și dureroase.

În cazuri severe pot să se înregistreze angină pectorală, orbire monoculară tranzitorie, papilită bilaterală, colită ischemică, vasoconstricția arterei renale, gangrenă a extremităților, necroză hepatică, tulburări mentale, delir, dispnee, hipotensiune sau hipertensiune arterială, puls slab, spasme musculare, convulsii, șoc și deces.

Tratamentul supradozajului sever constă în măsuri generale de susținere și tratament simptomatic. Inducerea vomiei și lavajul gastric sunt importante timp de 4 ore după supradozaj, precum și administrarea de cărbune activat. Utilizarea de preparate mucilaginoase poate reduce iritația gastrică. Extremitățile trebuie menținute în căldură și eventual pot fi administrate vasodilatatoare precum heparina. În caz de necroză hepatică, secundară la administrarea de paracetamol, acetilcisteina ar trebui să se administreze în primele 24-36 ore, deoarece este mai eficientă dacă este administrată mai devreme.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1. Proprietăți farmacodinamice

Codul ATC N02CA52 - preparate antimigrenoase, alcaloizi de ergotamină.

AGENȚIA MEDICAMENTULUI
ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE
MD-2026, m.m. Chișinău, str. Korolanko, 2/1
SECȚIA EXPERTIZĂ
SPECIALIZATĂ MEDICAMENTE

Paracetamol: Produce efectul analgezic și antipiretic prin mecanism care nu este complet studiat, dar care poate fi similar cu cel al salicilaților. În termeni de analgezie, paracetamol poate acționa prin inhibarea sintezei de prostaglandine în sistemul nervos central, și, la un nivel inferior, blocarea generării impulsului de durere, periferic. Acțiunii periferice poate fi, de asemenea, atribuită inhibarea prostaglandinelor sau inhibarea sintezei și/sau acțiunii altor substanțe care fac receptorii durerii sensibil la stimulare mecanică sau chimică.

Cafeina: Este o metilxantină, care în mod natural este prezentă în ceai și cafea, dar este un preparat sintetic pentru uz comercial. Cafeina potențează acțiunea alcaloizilor de ergot în tratamentul migrenei, prin creșterea absorbției gastrointestinale de ergotamină. Cafeina poate contribui, de asemenea, la vasoconstricție cerebrală și reducerea ulterioară a fluxului sanguin și presiunea locală a oxigenului. Poate fi administrată în asociere cu analgezice, precum paracetamol, în tratamentul cefaleei. Cafeina nu exercită nici un efect analgezic intrinsec; totuși preparatele care conțin cafeină au fost descrise ca având un efect analgezic rapid și mai puternic, permițând astfel ca dozele de substanțe analgezice să fie reduse.

Tartrat de ergotamină: Ergotamina este un alcaloid de ergot, care continuă să fie un agent important în tratamentul simptomatic al cefaleei migrenoase, în special în cazul pacienților pentru care medicamentele similare aspirinei determină numai ameliorare parțială. Ergotamina posedă efecte farmacologice complexe. În doze terapeutice provoacă vasoconstricție periferică, stimularea receptorilor alfa-adrenergici și suprimarea centrelor vasomotorii centrale.

Mecanismul prin care acționează ergotamina în cefaleea vasculară este, probabil, din cauza vasoconstricției directe a arterei carotide externe, ceea ce duce la scăderea amplitudinii pulsului. Efectele medicamentului asupra catecolaminelor și serotoninei sunt de asemenea implicați în eficacitatea terapeutică.

Alcaloizi de Belladonna: Sunt medicamente anticolinergice. Cu toate acestea, dozele utilizate în MIGRETIL nu sunt suficiente pentru a produce astfel de efecte. Stază gastrică, greața și vărsăturile sunt simptome și semne prezente în cele mai multe cazuri de migrenă. Alcaloizi de Belladonna exercită un efect antiemetic benefic, contribuind la ameliorarea simptomelor atacului de migrenă.

5.2. Proprietăți farmacocinetice

Paracetamol: Este absorbit rapid și complet din tractul gastrointestinal. Concentrația plasmatică maximă se realizează timp de 10-60 min. După administrarea a unei doze de 500 mg, concentrația maximă constituie 2,1 μg/ml. Se distribuie rapid și uniform în majoritatea țesuturilor, inclusiv se excretă în laptele matern. Trece bariera placentară. Aproximativ 25% de paracetamol se fixează de proteinele plasmatice. Timpul de înjumătățire plasmatic constituie 1,25-3 ore. Se metabolizează în ficat de către enzimele microsomale. Aproximativ 80-85% din doza administrată se supune conjugării în principal cu acidul glucuronic și mai puțin extensiv cu acidul sulfuric. O cantitate mică se conjugă cu cisteina. Paracetamolul se excretă prin urină, liber sau conjugat. Aproximativ 85% din doză se excretă în urină timp de 24 ore după administrarea unei singure doze.

Cafeina: Se absoarbe bine din tractul gastrointestinal, după administrarea internă absorbția fiind mai mare decât absorbția după administrarea intramusculară. După administrarea internă a 100 mg de cafeină, concentrația plasmatică maximă constituie 1,5-1,8 μg/ml, care se realizează peste 50-75 minute. Distribuția este largă și rapidă, trece bariera hemato-encefalică și placentară, se excretă în laptele matern.

Aproximativ 17% de cafeină se fixează de proteinele plasmatică. Cafeina este parțial demetilată, oxidată și acetată în ficat, și metabolizată ei se excretă în urină. Numai 1% se excretă sub formă nemodificată. Timpul de înjumătățire plasmatic constituie 3-4 ore la adulți, și poate constitui peste 100 ore la nou-născuți.

Tartrat de ergotamină: După administrarea internă, absorbția tartratului de ergotamină variază. Aceasta este redusă de staza gastrică, care în mod normal însoțește migrena. Absorbția este mai mare în prima oră după administrarea orală, în special atunci când medicamentul este administrat cu cafeina. Efect de prim pasaj hepatic contribuie la reducerea biodisponibilității. Trece bariera hemato-encefalică, se excretă în laptele matern. Aproximativ 95% se fixează de proteinele plasmatică. Concentrația plasmatică maximă se realizează timp de 2 ore, se reduce în jumătate în cazul administrării concomitente cu cafeina. Debutul acțiunii depinde de cât de prompt medicamentul este administrat după instalarea cefaleei. După administrarea orală de ergotamină la persoanele cu funcție renală și hepatică normală, concentrațiile plasmatică au scăzut bifazic, cu un timp de înjumătățire de 2,7 ore în faza inițială și 21 de ore în faza terminală. Ergotamina, în special porțiunea peptidă a moleculei, este metabolizată, probabil în ficat. Unele dintre metabolizii săi sunt farmacologic activi. Principala cale de excreție sunt masele fecale și numai aproximativ 4% din doză este excretată în urină.

Alcaloizi de Belladonna: Se absoarbe bine din tractul gastrointestinal. Există puține informații privind distribuția, metabolismul și excreția lor. Acestea sunt, probabil, hidrolizați de tropine și de acid tropic, derivații sunt apoi excretați în urină, și într-o măsură mai mică, în masele fecale.

5.3. Date preclinice de siguranță

Compușii MIGRÉTIL nu au fost supuși unor studii de mutagenitate și carcinogenitate; cu toate acestea nu există rapoarte cu privire la oricare dintre aceste efecte la om, în pofida utilizării îndelungate în practica clinică a acestor compuși, separat sau combinate.

Deoarece ergotamina poate provoca avort și malformații fetale, ar trebui să fie evitată utilizarea preparatului în timpul sarcinii.

Mod de administrare

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1. Lista excipienților

Povidonă, acid tartaric, celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, stearat de magneziu, Eudragit E100, hipromeloză, dietilftalat, Opaspray K-1-7000.

4.3. Contraindicații

6.2. Incompatibilități

Sulfatul de atropină este incompatibil cu alcalii, acidul tanic și sărurile de mercur. Bromhidratul de scopolamină este incompatibil cu alcalii, sărurile de argint și acidul tanic.

6.3. Perioada de valabilitate

2 ani.



6.4. Precauții speciale de păstrare

A se păstra la temperatura sub 30 °C, în ambalajul original.

6.5. Natura și conținutul ambalajului

Câte 20 sau 60 comprimate filmate în blistere PVC/ALU sau ALU/ALU, plasate în cutii de carton.

Nu toate mărimile de ambalaj pot fi disponibile pe piață.

6.6. Precauții speciale pentru utilizare și manipulare

Nu sunt cerințe speciale.

7. Deținătorul Certificatului de Înregistrare

BIAL – Portela & Ca, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugalia

8. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August 2015 .